



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رضا عبده على عاشور
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : اوسيم
رقم البطاقة : 26309192100428 رقم التليفون : 01224678216
العنوان : ..
العمر (تاريخ الميلاد) : 19-09-1963 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....)
المقرر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الأورام [11129]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رضا عبده علي عاشور National ID: 26309192100428	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقق الشخصية

رضا

عنده على عاشور

تربية النجارون

مركز أوسيم - الجيزة

٢٦٣٠٩١٩٢١٠٠٤٢٨

١٣٧٤٥١٦٥١

١٧٩٨٦٤٤٤١
٢٤١٥٣٥٨١



٢٠٢٦/٠٥ ٢٦٣٠٩١٩٢١٠٠٤٢٨

ربة منزل



لينة

٢١

٥٠

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٥/١٠



Patient's Name: Reda Abdu Ali Ashour
Date: 2026-08-27
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 50-year-old female with right breast palpable lump

Findings:

left breast.

- Predominantly fatty breast parenchyma . (ACRa)
- UOQ, posterior third irregular high density mass lesion with distortion
- **Ultrasound** demonstrated 12 o'clock RT UOQ irregular speculated hypoechoic non parallel mass surrounded with echogenic rind measuring 27x1.3 cm 9 cm from the nipple .
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs..

right breast.

- Predominantly fatty breast parenchyma. (ACR a)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- Right **breast (BIRADS 4c): 12 o'clock malignant looking lesion for biopsy .**
- left **breast (BIRADS 1): Normal study.**

Best Regards,

DR. Dina Sayed,Msc,CUDBIT



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

رضا
عبدہ علی عاشور
قرية البراجيل
مركز أوسيم - الجيزه

٢٠١٩/٠٩/٢٨

٢٨ ٠٠٤ ٢١ ١٩ ٠٩ ٦٣ ٢

LT2491691

Patient Name	رضا عبد علي عثور	Case No.	362253
Sex/Age	Female 63 Y	Patient No.	26653
Registered Date	03/9/2026 08:51:15 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	27/9/2026 02:29:03 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	27/9/2026 02:32:55 PM	Pathology No.	2847/26

Pathology Report

Clinical Data: Left UOQ breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 3/09/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Gross Examination.**
- Three fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.8 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

- Reagents.**
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
 - P63 clone (4A4), SYNAPTOPHYSIN clone (SP11), ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histopathological examination revealed papillary tumor formed of delicate papillary fronds with fibrovascular cores with pushing borders within cystically dilated duct surrounded by thick capsule.

Results:

- * IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- P63: Negative
- SYNAPTophysin: Negative
- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane staining in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 5%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Consistent with Encapsulated papillary/ solid papillary carcinoma.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%;



خليفة ربيع (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Msr El Qadima - Cairo, Egypt



Gustave Roussy International- Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي افتر نيشنل - مصر -معمل الباثولوجي



Patient Name	رضا عبده علي عاشور	Case No.	362253
Sex/Age	Female 63 Y	Patient No.	26653
Registered Date	03/9/2026 08:51:15 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	27/9/2026 02:29:03 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	27/9/2026 02:32:55 PM	Pathology No.	2847/26

2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim. MD



غرفة رقم (4) - الشعاع النووي - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر (القاهرة) - 3 مارس
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية

رضا

عبدہ علی عاشور

قرية البراجيل

مركز أوسيم - الجيزه

٢٠١٩/٠٩/٢٣

٢٨ ٠٠٤ ٢١ ١٩ ٠٩ ٦٣ ٢

LT2491691

Patient Name	رضا عبيد على عاشور	Case No.	362253
Sex/Age	Female 63 Y	Patient No.	26653
Registered Date	03/9/2026 08:51:15 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	27/9/2026 02:29:03 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	27/9/2026 02:32:55 PM	Pathology No.	2847/26

Pathology Report

Clinical Data: Left UOQ breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 3/09/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Three fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.8 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
 - P63 clone (4A4), SYNAPTOPHYSIN clone (SP11), ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histopathological examination revealed papillary tumor formed of delicate papillary fronds with fibrovacular cores with pushing borders within cystically dilated duct surrounded by thick capsule.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- P63: Negative
- SYNAPTOPHYSIN: Negative
- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane staining in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 5%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Consistent with Encapsulated papillary/ solid papillary carcinoma.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%;



Patient Name	رضا عبده علي عاشور	Case No.	362253
Sex/Age	Female 63 Y	Patient No.	26653
Registered Date	03/9/2026 08:51:15 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	27/9/2026 02:29:03 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	27/9/2026 02:32:55 PM	Pathology No.	2847/26

2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim. MD

